

Università degli studi di Milano

Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica

Sicurezza nelle Architetture Data Intensive

Titolo del progetto

Docente: Ernesto Damiani

Anno: I° Anno

Trimestre: III° Trimestre

Anno Accademico: 2025/2026

Componenti del gruppo:

Giuseppe Corasaniti - Matricola 84237A

Giuseppe Favata - Matricola 84231A

Matteo Toso - Matricola 85540A

Indice

1	Architettura del sistema	2
1.1	Ambito del sistema e integrazione con B4	2
1.2	Pipeline di elaborazione e decisione clinica	3
1.2.1	Stage 1 - Classificazione dell'urgenza con EfficientNet-B4	3
1.2.2	Stage 2 - Descrizione clinica con Qwen2-VL	3
1.2.3	Stage 3 - Recupero di casi clinici simili	4
1.2.4	Stage 4 - Sintesi clinica con BioMistral	4
1.2.5	Adaptation layer e assegnazione della priorità	4

1. Architettura del sistema

DermaTriage è un sistema di triage dermatologico assistito da intelligenza artificiale, sviluppato nell'ambito del progetto AI vs Cancer. Il sistema elabora immagini di lesioni cutanee inviate dai pazienti insieme a informazioni cliniche e demografiche, con l'obiettivo di stimare il livello di urgenza del caso e assegnare una priorità clinica compresa tra P1 e P4.

DermaTriage è integrato con la piattaforma B4 (Social Things), che rappresenta il punto di interazione con il paziente e mette a disposizione le API utilizzate per lo scambio dei dati relativi ai consulti, ai documenti caricati, ai risultati diagnostici e alle validazioni mediche. L'elaborazione diagnostica viene invece eseguita dal servizio DermaTriage, che espone un'applicazione FastAPI e implementa una pipeline di intelligenza artificiale composta da quattro stadi, seguita da un adaptation layer responsabile della conversione del risultato nella scala clinica P1-P4.

1.1. Ambito del sistema e integrazione con B4

L'interazione con il paziente avviene attraverso la piattaforma B4, che raccoglie le informazioni necessarie per avviare il processo di triage. Nel flusso principale vengono acquisiti un'immagine della lesione cutanea, l'età del paziente, il sesso e la localizzazione anatomica della lesione. A questi dati possono aggiungersi informazioni relative alla sintomatologia, tra cui prurito, sanguinamento, crescita della lesione, cambiamenti morfologici e dolore.

Una volta raccolti i dati, DermaTriage accede alle informazioni associate alla richiesta attraverso le API messe a disposizione da B4. Il servizio può recuperare le pratiche disponibili, individuare i documenti associati e scaricare l'immagine dermatologica necessaria all'elaborazione. Al termine della pipeline diagnostica, il risultato viene restituito a B4 e associato alla relativa richiesta di triage. La successiva validazione da parte del personale medico permette di ottenere un riscontro sull'esito prodotto dal sistema. Tali informazioni possono essere recuperate da DermaTriage e utilizzate come feedback per l'evoluzione dei prompt e per il retraining del classificatore EfficientNet-B4.

La comunicazione tra DermaTriage e B4 avviene tramite API REST protette da autenticazione. L'accesso ai servizi B4 utilizza un Bearer JWT ottenuto tramite l'endpoint `/api/v1/auth/token`; la gestione del token è affidata al componente `B4Auth`, che ne esegue il rinnovo automatico alla scadenza. I parametri necessari all'integrazione, tra cui credenziali, API key e indirizzo del servizio B4, sono configurati mediante variabili d'ambiente dedicate.

Il flusso integrato viene avviato attraverso l'endpoint `POST /diagnose`, al quale viene fornito un `consulto_id` come riferimento alla richiesta da elaborare. L'accesso a questo

endpoint richiede l'header `X-API-Key`, utilizzato anche per le funzionalità amministrative relative alla validazione delle diagnosi, alla gestione dei prompt e al retraining dei modelli.

Accanto al percorso integrato con B4, DermaTriage espone anche `POST /analyze`, che permette di avviare direttamente la pipeline fornendo un'immagine JPEG o PNG insieme a età, sesso e localizzazione. Questo secondo percorso consente quindi di utilizzare il motore diagnostico anche senza partire da una richiesta già presente sulla piattaforma B4.

Dal punto di vista architetturale, B4 e DermaTriage mantengono ruoli distinti. B4 gestisce l'interazione iniziale con il paziente e rende disponibili i dati necessari al processo di triage, mentre DermaTriage esegue l'elaborazione diagnostica e gestisce i meccanismi di aggiornamento dei modelli. L'integrazione tra i due sistemi è quindi bidirezionale e accompagna il caso clinico dalla fase di acquisizione fino alla restituzione e alla successiva validazione del risultato.

1.2. Pipeline di elaborazione e decisione clinica

L'elaborazione interna di DermaTriage segue una sequenza di quattro stadi, ognuno dei quali produce informazioni utilizzate nelle fasi successive. L'architettura combina un classificatore visuale, un modello vision-language, un sistema di retrieval basato su casi clinici e un modello linguistico specializzato in ambito medico. Il risultato ottenuto al termine di questi passaggi viene successivamente trasformato nella priorità clinica utilizzata dal sistema.

1.2.1. Stage 1 - Classificazione dell'urgenza con EfficientNet-B4

Il primo stadio esegue una classificazione dell'immagine della lesione attraverso EfficientNet-B4, un modello convoluzionale sottoposto a fine-tuning per distinguere tre livelli di urgenza denominati `HIGH`, `MEDIUM` e `LOW`. L'immagine viene elaborata come input RGB di dimensione 380×380 pixel e il modello restituisce, oltre alla classe prevista, un valore di confidenza e le probabilità associate alle tre classi.

Per aumentare la sensibilità verso i casi considerati più urgenti, la classificazione `HIGH` utilizza una soglia operativa pari a 0.25. Questa prima valutazione non determina direttamente la priorità finale P1-P4, ma costituisce una delle informazioni utilizzate nelle fasi successive della pipeline.

1.2.2. Stage 2 - Descrizione clinica con Qwen2-VL

In parallelo alla classificazione dell'urgenza, l'immagine viene analizzata da Qwen2-VL-7B-Instruct. Il modello interpreta visivamente la lesione e genera una descrizione clinica testuale organizzata in cinque aspetti principali, relativi alla forma, ai bordi, al colore, alla texture e alla presenza di caratteristiche considerate sospette.

Questo passaggio trasforma quindi il contenuto visuale in una rappresentazione testuale strutturata. La descrizione prodotta non rappresenta ancora una decisione diagnostica, ma viene utilizzata come query per la fase di ricerca dei casi clinici simili.

1.2.3. Stage 3 - Recupero di casi clinici simili

Il terzo stadio introduce un meccanismo di Retrieval-Augmented Generation basato su ChromaDB. La descrizione generata da Qwen2-VL viene convertita in una rappresentazione vettoriale mediante il modello `all-MiniLM-L6-v2` e confrontata con le descrizioni presenti nell'indice vettoriale.

La ricerca utilizza la similarità coseno e seleziona i cinque casi più vicini alla descrizione della lesione corrente. Per ciascun risultato vengono recuperate informazioni quali l'identificativo anonimizzato del paziente, la diagnosi associata, il livello di urgenza e il punteggio di similarità. In questo modo la pipeline affianca alla valutazione dell'immagine un riferimento a casi clinici precedenti con caratteristiche semanticamente simili.

1.2.4. Stage 4 - Sintesi clinica con BioMistral

Le informazioni prodotte nei primi tre stadi vengono successivamente aggregate e fornite a BioMistral-7B insieme ai dati relativi alla sintomatologia del paziente. Il modello riceve quindi la classificazione prodotta da EfficientNet-B4, la descrizione visuale generata da Qwen2-VL e i casi recuperati dal sistema RAG, disponendo di un contesto più ampio rispetto a quello disponibile nei singoli stadi precedenti.

BioMistral produce una risposta strutturata contenente il livello finale di urgenza, la relativa confidenza, una motivazione della decisione, l'azione raccomandata e una possibile patologia associata. Questo risultato rappresenta l'uscita della componente di inferenza vera e propria e viene successivamente elaborato dall'*adaptation layer*.

1.2.5. Adaptation layer e assegnazione della priorità

L'*adaptation layer* converte il livello di urgenza prodotto dalla pipeline nella scala P1-P4 utilizzata per il triage. La funzione `map_urgency_to_p_scale()` applica una serie di regole che tengono conto sia della classe di urgenza sia, per i casi **HIGH**, del livello di confidenza ottenuto.

Un risultato **HIGH** con confidenza superiore a 0.85 viene associato alla priorità P1, con un tempo previsto di presa in carico pari a 24 ore. Gli altri casi **HIGH** vengono assegnati a P2 con un intervallo di 48 ore, mentre le classi **MEDIUM** e **LOW** vengono convertite rispettivamente in P3, con 72 ore, e P4, con 7 giorni.

L'output finale comprende quindi la priorità P1-P4, il livello di confidenza, lo specialista indicato e il relativo SLA. L'*adaptation layer* separa in questo modo il risultato interno prodotto dai modelli dalla rappresentazione utilizzata per il triage clinico.